Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 21ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0115906-98.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc.

MARIA JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, alegando ser segurada da ré, na condição de dependente de seu marido, bem como ter histórico clínico de infarto agudo no miocárdio, em 2017, evoluindo com insuficiência cardíaca e doença renal.

Afirma que, em razão do seu quadro de saúde, o médico que assiste a paciente Autora, Dr. AUDES FEITOSA, (CRM-PE 12.162) prescreveu – mediante justificativa técnica – o tratamento com o uso do medicamento REPATHA (EVOLOCUMABE/REPATHA – id. 145467803).

Nada obstante, realizado o pedido administrativo de custeio da medicação junto ao plano de saúde, a demandada negou a solicitação, ao argumento de inexistência de cobertura contratual (id. 145467806).

Diante do narrado, a parte autora pugnou pela concessão de tutela de urgência ré autorize o custeio integral do tratamento prescrito pelo médico assistente (id. 145467803/ 145467805). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência vindicada e julgados totalmente procedentes os pedidos da peça exordial, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura assistencial pela CASSI e condená-la à obrigação de fornecer e custear 1 injeção de 140 mg de REPATHA (EVOLOCUMABE) a cada 4 semanas, de acordo com a prescrição do médico assistente.

Em decisão de id. 149997531, foi indeferida a tutela provisória de urgência requerida, bem como foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela autora.

Citada, a demandada apresentou contestação (id. 148736169), impugnando, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça deferido e o valor atribuído à causa. No mérito, afirma não haver dever de cobertura de medicamentos farmacêuticos, alimentos, suplementos ou qualquer outro insumo de uso domiciliar prescritos por médicos, por não fazerem parte da natureza do contrato de um plano de saúde, conforme entendimento da ANS e do STJ. Aduz ainda que o contrato de saúde possui cláusula expressa de exclusão de cobertura, e que, portanto, não há ilícito por parte da ré na negativa. Requereu, assim, a improcedência dos pleitos declinados na inicial.

A parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar (id. 166778854).

Réplica de id. 172777950.

Intimadas para informar se pretendiam produzir outras provas, as partes se manifestaram, requerendo o julgamento antecipado do feito.

Malote digital (id. 175023874) informou a decisão proferida monocraticamente pelo relator Des. Ruy Trezena Patu Júnior, que deu provimento ao agravo de instrumento (0014061-41.2024.8.17.9000).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar. Passo a decidir.

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória.

Quanto à impugnação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária apresentada pela parte ré, tenho que não merece prosperar. Não obstante a irresignação da demandada, esta não trouxe à baila nenhum elemento capaz de evidenciar a apontada condição financeira da parte autora para arcar com os custos da demanda.

No tocante à impugnação ao valor da causa, também não assiste razão ao demandado, pois, no caso dos autos, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da obrigação de fazer, qual seja, o tratamento continuado com a medicação REPATHA (EVOLOCUMABE), orçada em R$ 1.396,70.

Destarte, considerando a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor, estima-se o valor da causa em R$ 18.157,10, motivo pelo qual deixo de acolher a impugnação ao valor da causa, nos termos dos arts. 291 c/c 292, II, do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise do mérito.

A questão posta nos autos, fundamentalmente, visa a perquirir sobre a licitude da negativa de cobertura integral de tratamento médico perpetrada pela operadora de plano de saúde.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Os documentos colacionados aos autos, em especial o laudo da lavra do Dr. Audes Feitosa, CRM 12162/PE RQE 933, CRM/PE – 23925, dão conta do grave estado de saúde da demandante e da necessidade de implementação do tratamento prescrito, nos termos do laudo médico de id. 147388351:

> “Dada a condição de muito alto risco cardiovascular de Maria José e a insuficiência no controle do colesterol, mesmo após doses máximas de estatina e ezetimiba ajustadas para sua doença renal, é fortemente aconselhado o uso de Repatha como uma crucial adição ao seu regime terapêutico. A utilização deste medicamento visa melhorar o perfil lipídico da paciente, possibilitando a redução do risco de futuros eventos cardiovasculares graves.”

Em sua defesa, a ré afirma a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura, bem como a ausência de obrigatoriedade legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar, conforme inciso VI, do artigo 10 e alínea "g", do inciso II, do artigo 12 da Lei nº 9.656/1998[1] (file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftn1).

Nesse ponto, importante esclarecer que, em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar. Assim, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

Isso porque, em regra, os planos de saúde somente são obrigados a custear os fármacos usados durante a internação hospitalar. As exceções ficam por conta dos antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), os medicamentos utilizados no home care e os remédios relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS, conforme inciso VI, do artigo 10 e alínea "g", do inciso II, do artigo 12 da Lei nº 9.656/1998[2] (file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-

%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftn2) acima referidos.

Também de acordo com a jurisprudência do STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida ("home care") e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.071.979/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024 e AgInt no AREsp n. 1.771.350/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.

No caso dos autos, a autora não faz uso de medicamento antineoplásico (para tratamento de câncer), tampouco conta com assistência por meio de “home care”, pretendendo apenas ter custeado o medicamento REPATHA (EVOLOCUMABE) para uso domiciliar.

Todavia, há particularidades no caso em exame que justificam a aplicação de entendimento diverso, à semelhança do entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AREsp 2.251.773-DF, que afirmou ser abusiva negativa de tratamento essencial ao controle de doença degenerativa do sistema nervoso, apenas por ser o medicamento administrável na forma oral em ambiente domiciliar, quando, entre outras circunstâncias, esteja incluído no rol da ANS e faça parte de específico tratamento escalonado pelo qual o paciente necessariamente precisa passar para ter direito ao fornecimento de fármaco de cobertura obrigatória.

Assim, na espécie, a indicação feita pelo médico assistente da parte autora estabelece a imprescindibilidade da terapia com o específico medicamento REPATHA (EVOLOCUMABE), com a aplicação de uma dose, a cada 4 semanas. Ademais, em consulta ao bulário eletrônico da Anvisa[3] (file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftn3), constata-se que o medicamento conta com o devido registro (nº 102440007) e é expressamente indicado para o tratamento de adultos com um alto nível de colesterol no sangue e com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida (um histórico de ataque cardíaco, derrame ou problemas nos vasos sanguíneos), como é o caso dos autos.

E, em que pese o referido fármaco não esteja previsto como de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos de Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, há diretrizes nacionais e internacionais indicam o uso da medicação para a condição de saúde da parte autora. Ademais, há nos autos relatório médico esclarecendo que a paciente já fez uso prévio de outras terapias, com utilização de outros fármacos, sem sucesso, concluindo pela necessidade da medicação prescrita, veja-se:

> “Apesar das doses máximas de estatina e ezetimiba permitidas pela doença renal, a paciente apresenta um controle inadequado do colesterol, com a meta estabelecida em < 50 mg/dL. Nesse contexto, é necessário buscar alternativas terapêuticas mais efetivas.”

Acrescente-se ainda que, na distribuição do ônus da prova, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é a redação do artigo 373, do CPC.

Destarte, do argumento trazido aos autos pelo demandado acerca do não cabimento do atendimento domiciliar nos termos do laudo médico prescrito, caberia ao mesmo demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele.

Contudo, intimada para informar se pretendia produzir outras provas, a exemplo de prova pericial a ser produzida por *expert* do juízo, a ré manifestou-se requerendo o julgamento antecipado do feito, não se desincumbindo de comprovar a prescindibilidade do tratamento com a medicação solicitada.

Destarte, existindo indicação expressa para o referido tratamento, como houve no presente caso pelo médico assistente acima citado, é abusiva a negativa do plano de saúde a tratamento domiciliar que visa reduzir o risco de eventos cardiovasculares.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação da ré na obrigação de fazer correspondente ao fornecimento medicamento REPATHA (EVOLOCUMABE/REPATHA) tudo nos moldes requeridos pelo médico assistente da parte autora (id. 145467803), **confirmando os termos da decisão de id nº 175023874.**

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para pagar as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Recife, 30 de julho de 2024.

Nehemias de Moura Tenório

Juiz de Direito

---

[1] (file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftnref1) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, **ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;** (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)(...)
II - **quando incluir internação hospitalar**: (...)
g) **cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral,** procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
(file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftnref2)

[3] (file://tjpe171073/P%C3%BAblico/_%20SE%C3%87%C3%83O%20A%20-%20Gabinete/_Servidores/3.%20Gabriella/0023516-75.2024.8.17.2001.%20senten%C3%A7a%20-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-negativa%20home%20care%20-%20%C3%B4nus%20da%20prova%20procedente.doc#_ftnref3) https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/

Assinado eletronicamente por: NEHEMIAS DE MOURA TENORIO
30/07/2024 13:39:37
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 177330077

24073013393683000000173063912

IMPRIMIR GERAR PDF